الهيئة العامة للإحصاء
General Authority for Statistics

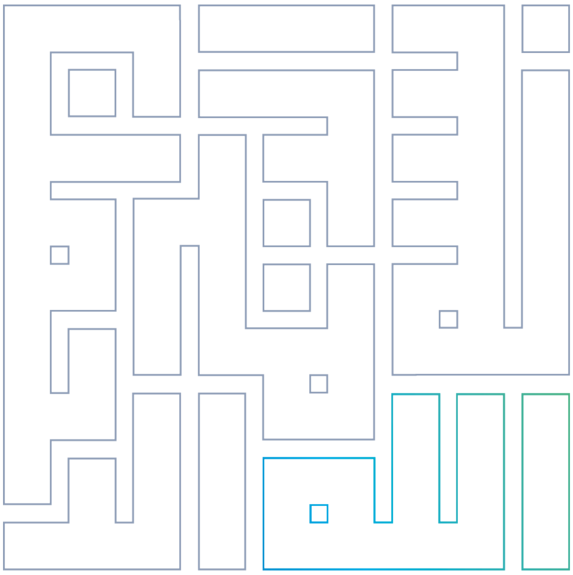
65 عاماً
YEARS

تقرير

إحصاءات الأشخاص ذوي الإعاقة

2023م

stats.gov.sa



VISION رؤيــــة
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

www.stats.gov.sa

المحتويات

3 المقدمة
4 أهداف المسح ومنهجية المسح
6 نطاق وشمول العينة
7 التصانيف المستخدمة
8 استمارة المسح
9 المفاهيم والمصطلحات
12 انتشار الإعاقة (تعداد 2022م)
13 انتشار الصعوبة (تعداد 2022م)
15 المؤشرات الديموغرافية (مسح الإعاقة 2023م)
19 المؤشرات العملية والاجتماعية (مسح الإعاقة 2023م)
21 المؤشرات التنموية (مسح الإعاقة 2023م)
25 المؤشرات الأسرية (مسح الإعاقة 2023م)
29 مؤشرات المسكن (مسح الإعاقة 2023م)

المقدمة

يُعد مسح الأشخاص ذوي الإعاقة من المسوح الأسرية المهمة التي تُجرى بالعينة، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء كل ثلاث سنوات بتنفيذ هذا المسح من خلال إدارة إحصاءات السكان والنوع الاجتماعي والتنوع. ويسر الهيئة أن تقدم هذا التقرير الخاص بالأفراد ذوي الإعاقة، والذي يمثل عام 1445/1444هـ (الموافق 2023م).

وقد اعتمدت الهيئة في عرض بيانات هذا التقرير على مصدرين اثنين للبيانات، هما: المصدر الأول تعداد السعودية 2022م، والذي يستعرض نسب انتشار الإعاقة في المملكة العربية السعودية، فيما يُعدُّ مسح الإعاقة موجهة خلال الفترة من (2023/09/18م) إلى المصدر الثاني للبيانات، والذي تم تنفيذه ميدانيًّا على عينة (2023/10/05م) واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفَّرته نتائج تعداد السعودية 2022م، وقد غطى المسح جميع مناطق المملكة الإدارية الثلاث عشرة، ويتضمن التقرير شرحًا لمنهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية.

وتتقدم الهيئة العامة للإحصاء بالشكر لجميع الشركاء والعملاء من ذوي الإعاقة، ولأرباب الأسر الذين شاركوا معنا في هذه الدراسة، وكان لتعاونهم أكبر الأثر بعد توفيق الله في إنجاز المسح، وإصدار هذا التقرير.

والله ولي التوفيق.

الهيئة العامة للإحصاء.

أهداف مسح الأشخاص ذوي الإعاقة

- توفير بيانات عن السكان ذوي الإعاقة في المملكة من حيث الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى توفير بيانات عن أنواع الإعاقات، ومستوياتها من حيث شدتها.
- توفير بيانات حسب الصعوبات للأشخاص ذوي الإعاقة الوحيدة والمتعددة.
- رصد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبيان طبيعتها؛ لتمكين الجهات المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة من وضع أولوياتها ورسم سياساتها المتعلقة بهذا المجال.
- توفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة دوريًّا لقياس التغير مع مرور الزمن.
- إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال الخدمات والعناية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

منهجية المسح

1- تم استخدام نموذج WG/UNICEF Child Functioning Module (CFM) المعني بالأطفال في الفئات العمرية (17-2) سنة، ويشمل قياس الصعوبة في المجالات التالية:

م	قياس الصعوبة للفئة العمرية (4-2) سنوات	قياس الصعوبة للفئة العمرية (17-5) سنة
1	الرؤية	الرؤية
2	السمع	السمع
3	الحركة (المشي)	المشي والتنقل
4	الحركة الدقيقة (حركة الأصابع)	الاعتناء بالذات
5	التواصل	التواصل
6	التعلم	التعلم
7	اللعب	التذكر
8	التحكم في السلوك	التركيز
9		تقبل التغييرات
10		التحكم في السلوك
11		اكتساب الصداقات
12		القلق
13		الاكتئاب

2- نموذج مجموعة واشنطن (WG) "القائمة المطولة لأسئلة مجموعة واشنطن للصعوبة " Washington Group on Disability Statistics- Extended Questions" للفئة العمرية 18 سنة فأكثر والتي يتم استخدامها للمسوح المختصة بذوي الإعاقة، حسب توصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ويشمل قياس الصعوبة في المجالات التالية:

بحسب تصنيف مجموعة واشنطن المعنية بإحصاءات الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن قياس الصعوبات يتم حسب درجات شدة الصعوبة، وقد جُمعت بيانات مسح الإعاقة على أساس درجة شدة الصعوبة (الدرجة الأولى: خفيفة، الدرجة الثانية: شديدة، الدرجة الثالثة: بالغة أو لا يستطيع نهائيا)، حيث تشير الدرجة الأولى إلى الصعوبات الجسدية الخفيفة، والدرجتان الثانية والثالثة تشيران إلى الإعاقة.

م	قياس الصعوبة للفئة العمرية (18 سنة فأكثر)
1	الرؤية
2	السمع
3	الحركة (المشي أو صعود السلالم)
4	الحركة (أداء الجزء العلوي للجسم)
5	التواصل
6	الاعتناء بالذات
7	التذكر
8	التركيز
9	القلق
10	الاكتئاب

نطاق وشمول عينة المسح

تشمل عينة البحث أسر السعوديين والمقيمين الذين أعمارهم من سنتين فأكثر في المملكة العربية السعودية، وقد غطت عينة المسح 29،920 أسرة على مستوى المناطق الإدارية.

آلية جمع البيانات

يتم جمع بيانات مسح الإعاقة ميدانيًا من خلال إجراء مقابلات شخصية مع الأسر التي تحتوي على أفراد ذوي إعاقة أو أكثر. وتنفذ هذه المقابلات باستخدام تقنية مساعدة الكمبيوتر (CAPI)، وهي اختصار لـ "نظام جمع البيانات المدعوم بالحاسوب (Computer-Assisted-Personal-Interviewing) ويعتمد هذا النظام على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو الأجهزة الذكية لإدخال البيانات مباشرة أثناء المقابلة، مما يسهل جمع البيانات بدقة أكبر، ويوفر الوقت في معالجة البيانات الميدانية.

توزيع العينة على مستوى المناطق الإدارية للأسر التي يوجد فيها فرد واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما في الجدول التالي:

المنطقة	حجم العينة
الرياض	4,180
مكة المكرمة	4,220
القصيم	1,900
الشرقية	4,120
تبوك	1,840
حائل	1,420
جازان	1,960
نجران	1,440
المدينة المنورة	2,960
الجوف	1,180
الحدود الشمالية	1,040
الباحة	1,260
عسير	2,400

التصانيف المعتمدة والمستخدمة في المسح

- **الدليل الوطني للدول والجنسيات:**

هو تصنيفٌ دولي معياريٌّ موحَّد، شاملٌ للدول والمناطق الإدارية التابعة لها، ويعتمد هذا التصنيف على المعيار الدولي (ISO 3166)، وذلك من خلال إعطاء رموز للدول والمقاطعات التابعة لها، واستخدام هذه الرموز والأرقام بدلًا من استخدام اسم الدولة مفيد في الأغراض الإحصائية؛ مما يوفر الوقت ويجنب الأخطاء، والغرض من استخدام هذا التصنيف هو تصنيف الأفراد بحسب الجنسية إلى سعوديين وغير سعوديين.

- **التصنيف الدولي لتأدية الوظائف وحالات العجز والصحة (ICF):**

هو إطار عالمي وضعتْه منظمة الصحة العالمية (WHO) لتصنيف الإعاقة بمختلف أنواعها. يُستخدم هذا التصنيف لتحديد أنواع الإعاقات، وشدة الإعاقة، وتأثيرها على حياة الأفراد من حيث قدرتهم على تأدية وظائفهم اليومية ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

- **المعيار الدولي لتحديد حالة الإعاقة للمكاتب الإحصائية:**

1- أسئلة مجموعة واشنطن الموسعة (WG-ES) (WG Extended Set on Functioning) للفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وتُعد هذه الأسئلة المعيار الدولي لتحديد حالة الإعاقة، وقد طوَّر هذا المعيار ما يُعرف بمجموعة واشنطن، ويعتمِد على مجموعة من الأسئلة وُضِعَت لقياس شدة الإعاقة، والصعوبة التي ربما يواجهها الأفراد في أداء الأنشطة اليومية، وتُستخدم هذه الأسئلة بشكل دولي لجمع بيانات دقيقة حول الإعاقة.

2- مقياس اليونيسيف للإعاقة لدى الأطفال للفئه العمرية 2- 17 سنة.

استمارة المسح

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قِبل مختصين في الهيئة العامة للإحصاء، ورُوعي عند تصميم الاستمارة جميع التوصيات والمعايير والتعاريف المحلية والدولية، وتضمنت استمارة المسح مجموعة من الأسئلة مصنفة إلى عدة أقسام رئيسة على النحو التالي:

القسم الأول: أسئلة حول بيانات وخصائص الفرد ذي الإعاقة تضمنت:

1. الخصائص الديموغرافية.
2. الخصائص الاجتماعية.
3. الخصائص الاقتصادية.

القسم الثاني: أسئلة حول الإعاقة/ الصعوبات الوظيفية بحسب قائمة مجموعة واشنطن المطولة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر ونموذج (WG/UNICEF Child Functioning Module (CFM للفئة العمرية (2-17) سنة:

وقد تم اعتماد الأسئلة الرئيسة، واستخدام عدد من الأسئلة الفرعية التي تقدم معلومات مهمة للجهات ذات العلاقة بالإعاقة، مثل: استخدام النظارات أو العدسات الطبية، واستخدام المعينات السمعية، وأنواع المعينات المستخدَمة في الحركة، واستخدام لغة الإشارة). وتشمل الأسئلة الرئيسة الآتي لقياس الصعوبات في المجالات الوظيفية التالية:

- الرؤية.
- السمع.
- الحركة (المشي والتنقل).
- الحركة (أداء الجزء العلوي للجسم).
- العناية الشخصية.
- التواصل.
- التعلم.
- اللعب.
- التذكر.
- التركيز
- تقبل التغييرات.
- التحكم في السلوك.
- اكتساب الصداقات.
- القلق.
- الاكتئاب.

القسم الثالث: أسئلة ذات أهمية لفهم ظروف الإعاقة وأسبابها، وتضمنت الآتي:

- أسباب الإعاقة.
- مكان الإقامة المعتاد.
- خصائص الأسرة.
- أنواع الإعاقة.
- الإعاقة الواحدة والمتعددة.
- معرفة التشخيص ممن لديهم (التوحُّد، أو فرط الحركة وتشتت الانتباه، أو متلازمة داون، أو ثنائية القطب، وصعوبات التعلم).

المفاهيم والمصطلحات

عينة المسح	هي العينة المختارة من الإطار الإحصائي لإجراء مسح الإعاقة عليها، وتضمُّ هذه عينة من جميع الأفراد المقيمين في المملكة الذين أعمارهم من سنتين فأكثر (السعوديون وغير السعوديين).
المنطقة الإدارية	هي جزء من المملكة العربية السعودية يشرف على إدارتها جهاز حكومي تابع مباشرة لوزارة الداخلية، مثل منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة... إلخ، ويوجد في كل منطقة إدارية مدينة تكون مقرًا لها.
المحافظة	هي جزء من المنطقة الإدارية، وتُعد المستوى الإداري الأول ضمن مكوناتها وتتبعها إداريًّا، مثل محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.
المركز	هو جهة إدارية تابعة للمحافظة مثل مركز الدلم التابع لمحافظة الخرج، وبعضها يتبع لمقر الإمارة مباشرة مثل مركز عرقة التابع مباشرة لإمارة منطقة الرياض، وهناك مراكز تتبع مراكز أخرى مثل مركز عيينة التابع لمركز حالة عمار في منطقة تبوك.
المدينة	للأغراض الإحصائية يُعدُّ (مدينةً) كل مسمى سكاني به بلدية، أو يزيد عدد سكانه عن (5000) نسمة.
الأسرة المعيشية	هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل، ويقيمون في المسكن وقت المسح.
رب الأسرة	هو الشخص المسؤول عن معيشة الأسرة، ولا يقل عمره عن (15) سنة تقريبًا، وإذا كانت الأسرة مكونة من أطفال ووالدتهم ويرعى شؤونهم قريب لهم لكنه لا يقيم معهم ففي هذه الحال لا يُعدُّ هذا القريب ربًّا للأسرة؛ لأنه يُعد مع أسرته، وتكون الأم حينئذٍ هي رب الأسرة.
العمر	هو مقدار الفترة الزمنية من تاريخ ميلاد الفرد وتاريخ الوقت الذي يتم فيه الاتصال به، ويُعبر عن مقدار هذه الفترة بالسنوات الكاملة، مع إهمال الشهور والأيام مهما كان عددها.
الجنسية	هي تبعية الفرد القانونية لدولة معينة يمثلها ويتسمى باسمها، وتحدد عادة بجواز السفر الذي يحمله الفرد، أو الذي له الحق في الحصول عليه، ويتم كتابة الجنسية بالتفصيل.
منطقة العد	هي أصغر تقسيم إحصائي تم استخدامه في التعداد العام للسكان والمساكن، وتتكون من مساحة جغرافية تحتوي على عدد من المباني والمساكن والأسر تبلغ في المتوسط (150) أسرة.

الشخص ذو الإعاقة	كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. *تعريف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الإعاقة	هي أي قصور لدى الفرد في أي من الوظائف أو البنى الجسمية؛ والتي تؤدي إلى محدودية قدرته على المشاركة نتيجة للعوامل البيئية والشخصية. * تعريف منظمة الصحة العالمية WHO.
الأفراد ذوو الإعاقة	هم أشخاص أكثر عرضةً من السكان الآخرين لمواجهة قيود في أداء مهام محددة، أو المشاركة في نشاط ما، وذلك بسبب القصور في أداء الأنشطة الأساسية، مثل: المشي أو النظر أو السمع، حتى وإن تم تحسين الظروف باستخدام الأجهزة المساعدة أو البيئة الداعمة أو الموارد المتوفرة. وحسب تصنيف مجموعة واشنطن للصعوبة يتم قياس الصعوبات بدرجاتها الثلاث (خفيفة، أو شديدة، أو بالغة الشدة أي لا يستطيع). *تعريف مجموعة واشنطن للإعاقة.
النظارة الطبية	هي أداة طبية مُعِينة يستخدمها الشخص لتعينه في التغلب على مشكلة في البصر (يمكن أن تكون نظارة طبية أو عدسات طبية لاصقة).
المعينات السمعية	هي أداة طبية مُعِينة يستخدمها الشخص لتُعينه في التغلب على مشكلة في السمع (أي الضعف في السمع سواء كان خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا). ويمكن للمعينة السمعية أن تكون سماعة ظاهرة خارج الأذن، أو سماعة صغيرة جدًا وغير ظاهرة توضع داخل الأذن، كما يمكن أن تكون مكبرات الصوت التي تستخدم في صفوف الضعف السمعي أو القاعات.
المعينات المستخدمة في التنقل	هي المعينة الطبية التي يستخدمها الشخص لتعينه في التنقل (مثل: العكاز، والكرسي المتحرك العادي، أو الكهربائي، أو جهاز الوقوف، أو الأطراف الصناعية العلوية، أو السفلية، أو حتى المساعدة من شخص آخر).
صعوبة الرؤية	هي أن يعاني الفرد من صعوبة في رؤية الأشياء، حتى وإن استخدم نظارة طبية، والأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية هم الأشخاص الذين لديهم إشكالية في الرؤية تحد من قدراتهم على أداء واجباتهم اليومية.
صعوبة السمع	هي أن يعاني الفرد من صعوبة في سمع الكلام وفهمه، حتى وإن استخدم سماعة طبية، والأفراد الذين لديهم إعاقة سمعية هم الأشخاص الذين لديهم إشكالية في السمع تحد من قدراتهم على أداء واجباتهم اليومية.
صعوبة التواصل	هي عدم قدرة الفرد على التواصل مع الآخرين، مثل عدم قدرته على فهم ما يقوله الآخرون له، وعدم قدرة الآخرين على فهم ما يقوله هو لهم.
صعوبة الحركة	هي أن يعاني الفرد من صعوبة في تحريك الأجزاء السفلية من الجسم بصورة كلية أو جزئية، أو أن يعاني الفرد من صعوبة في المشي، أو الصعود باستخدام السلَّم (الدرج).
صعوبة التذكُّر أو التركيز	هي أن يعاني الفرد من صعوبة في تذكُّر أحداث ما، أو أنشطة معينة خلال يومين من حضوره أثناء حصولها أمامه، كما أنه لا يستطيع التركيز خلال حديثه مع الآخرين.
صعوبة الاعتناء بالذات	يُقصد بها عدم قدرة الفرد على الاعتناء بنفسه كالاغتسال بالكامل أو ارتداء ملابسه.

لغة الإشارة	هي مجموعة من الإيماءات والرموز اليدوية يستخدمها الصم وضعاف السمع. ويستخدمها كذلك أصحاب السمع السَّوِي للتخاطب مع الصم. وتعتمد لغة الإشارة على الأفكار أكثر من الكلمات، فكل إيماءة تُعبِّر عن فكرة أو مفهوم محدد. ولكن بعض الكلمات والأسماء لا مرادف لها في لغة الإشارة، ويستخدم الصمُّ الحروف الأبجدية اليدوية، أو أبجدية الأصابع، لمثل هذه الكلمات*. *وزارة الصحة السعودية.
القلق	هو شعور بعدم الارتياح، مثل التوتر أو الخوف، ويمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا. وقد يعترض هذا الشعور أي شخص*. *وزارة الصحة السعودية.
الاكتئاب	هو اضطراب المزاج الذي يسبب شعورًا متواصلًا بالحزن، وفقدان المتعة والشغف والاهتمام بالأمور المعتادة، ونقص التركيز، وقد يكون مصحوبًا بالشعور بالذنب وعدم الأهمية، ونقص تقدير الذات، ويؤثر المرض على المشاعر والتفكير والتصرفات*. *وزارة الصحة السعودية.
التشخيص	يُقصد به الوصف الصادر في تقرير معتمَد لتحديد نوع الحالة أو المرض وشدتها (بسيطة، أو متوسطة، أو شديدة) وفي حالات كثيرة يتضمن أسلوب أو طريقة العلاج.
مراكز التربية الخاصة (الرعاية والتأهيل)	هي المراكز التربوية التابعة للتعليم، وهي الجهة المنوط بها تقديم خدمات التدريب والتأهيل والخدمات التربوية للأطفال ذوي الإعاقة في القطاع العام، أو الأهلي، أو في القطاع التطوعي.
التوحُّد	هو اضطراب في النمو، يحدث في مرحلة مبكرة من الطفولة، ويؤثر في كيفية التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويتضمن أنماطًا محددةً ومتكررةً من السلوك، وقد أُضيف مصطلح "طيف التوحُّد" للإشارة إلى وجود مجموعة متعددة من الأعراض والعلامات على مستويات مختلفة من الشدة.* *وزارة الصحة السعودية.
متلازمة داون	هي اضطراب جيني يختلف من طفل لآخر في شدته مسببًا إعاقة ذهنية، وتأخرًا في النمو مدى الحياة، ويؤدي إلى وجود صعوبات في التعلم عند الأطفال المصابين به.* *وزارة الصحة السعودية.
فرط الحركة وتشتت الانتباه	هو أحد اضطرابات النمو العصبية التي تحدث في مرحلة الطفولة، وتستمر حتى مرحلتي البلوغ والرشد بأشكال وأعراض مختلفة.* *وزارة الصحة السعودية.
نوع الحيازة	هي صفة حيازة المساكن المشغولة بأسر التى تقيم فيها أثناء زيارة الباحث الميدانى خلال فترة الإسناد الزمني، وتصنف إلى (مملوكة – إيجار – مقدمة من صاحب العمل أو من العائلة أو من الجمعيات الخيرية –... إلخ).

مؤشرات الإعاقة والصعوبة (من تعداد السعودية 2022)

أولا: انتشار الإعاقة والصعوبة حسب الجنسيات:

أوضحت نتائج تعداد السعودية 2022 أن نسبة انتشار الإعاقة والصعوبة للسكان %4.2 حيث بلغت للسعوديين %5.9، أما لغير السعوديين %1.8.

المؤشر 1.1 نسبة انتشار الإعاقة حسب الجنسية:

المؤشر	سعودي	غير سعودي
نسبة انتشار الإعاقة حسب الجنسية	%2.7	%0.6

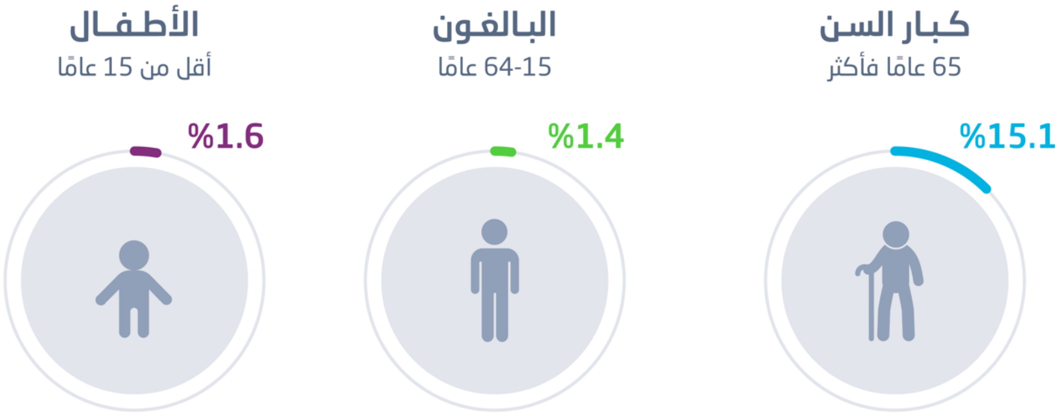
المؤشر 1.2 نسبة انتشار الإعاقة حسب الجنس:

المؤشر	الذكور	الإناث
نسبة انتشار الإعاقة حسب الجنس	%1.6	%2.1

المؤشر 1.3 نسبة انتشار الإعاقة حسب الفئة العمرية:

تزداد نسب انتشار الإعاقة بصورة كبيرة كلما زاد العمر، وذلك بحسب تحليل الفئات العمرية العريضة الثلاث: الأطفال (الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا)، والبالغون (الذين تتراوح أعمارهم بين 15و 64 عامًا)، وكبار السن (الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق).

نسبة انتشار الإعاقة حسب الفئة العمرية



ثانيا: انتشار الصعوبات:

أظهرت نتائج تعداد 2022 أن نسبة انتشار الصعوبة قد بلغت (2.8%) من إجمالي السكان في المملكة.

المؤشر 2.1 نسبة انتشار الصعوبة حسب الجنسية:

المؤشر	سعودي	غير سعودي
نسبة انتشار الصعوبة حسب الجنسية	3.8%	1.3%

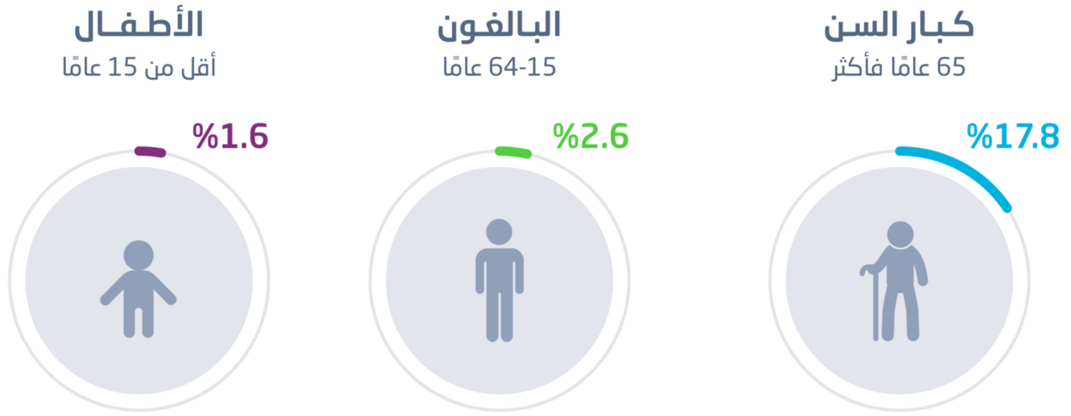
المؤشر 2.2 نسبة انتشار الصعوبة حسب الجنس:

المؤشر	الذكور	الإناث
نسبة انتشار الصعوبة حسب الجنس	2.6%	3.0%

المؤشر 2.3 نسبة انتشار الصعوبة حسب الفئة العمرية:

الفئات العمرية العريضة الثلاث: الأطفال (الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا)، والبالغون (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا)، وكبار السن (الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق).

نسبة انتشار الصعوبة حسب الفئة العمرية



مؤشرات الإعاقة والصعوبة من مسح الأشخاص ذوي الإعاقة 2023م

تمهيد:

تم سحب العينة المستهدفة من تعداد السعودية 2022م، وبلغ إجمالي العينة 29،920 أسرة، وتطبيقًا لمنهجية مجموعة واشنطن المعنيَّة بإحصاءات الإعاقة فقد تم تقسيم الصعوبة إلى ثلاث درجات، الدرجة الأولى: خفيفة (بعض الصعوبة)، الدرجة الثانية (شديدة)، الدرجة الثالثة: (بالغة) أو (لا يستطيع نهائيا)، حيث تشير الدرجة الأولى إلى الصعوبات الجسدية الخفيفة، والدرجتان الثانية والثالثة تشيران إلى الإعاقة.

أظهرت نتائج مسح الأفراد ذوي الإعاقة 2023م بحسب تصنيف درجات الصعوبة أن نسبة الأفراد الذين لديهم صعوبة خفيفة 31.8%، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة شديدة أو بالغة 68.2% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة في العينة المستهدفة.

وجميع المؤشرات في مسح الإعاقة مبنية على بيانات العينة المستهدفة التي تم اختيارها في مسح الإعاقة بناءً على إجابات الأسئلة المتعلقة بالإعاقة في التعداد السكاني2022م، وذلك لضمان تمثيل العينة بشكل دقيق للمجتمع المستهدف من حيث الخصائص الديموغرافية، مثل العمر والجنس والمنطقة الإدارية.

أولاً: المؤشرات الديموغرافية:

المؤشر 1.1: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة حسب الإعاقة الواحدة أو المتعددة حسب الجنس:

نوع الإعاقة	الجنس	
	ذكور	إناث
إعاقة واحدة	%45.0	%40.6
متعدد الإعاقات	%55.0	%59.4

*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشر 1.2: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الصعوبة الواحدة أو المتعددة حسب الجنس:

نوع الصعوبة	الجنس	
	ذكور	إناث
صعوبة واحدة	%50.8	%49.0
متعدد الصعوبات	%49.2	%51.0

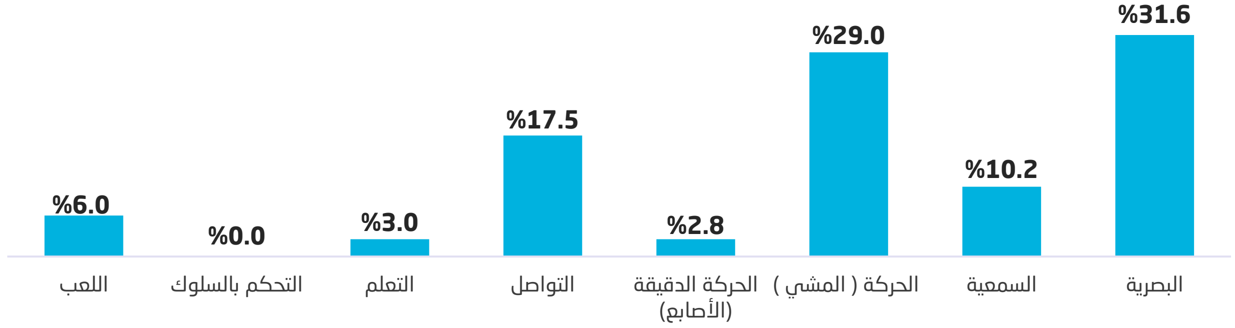
*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة فقط.

مؤشر 1.3: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة الواحدة أو المتعددة حسب الفئة العمرية:

الفئة العمرية	إعاقة واحدة	إعاقة متعددة
4 - 2	%31.8	%68.2
17- 5	%40.0	%60.0
18سنة فأكثر	%42.0	%58.0

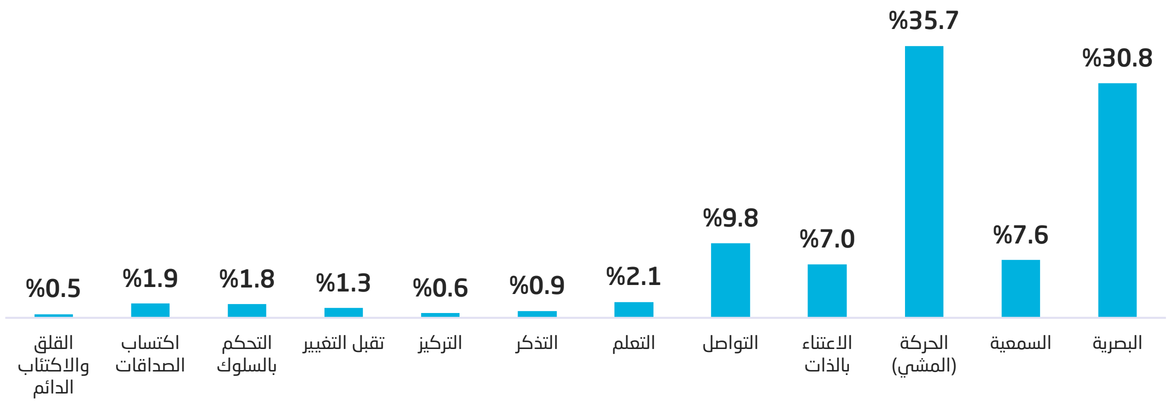
*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 1 : التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة الواحدة ونوع الإعاقة للفئة العمرية (2-4) سنوات



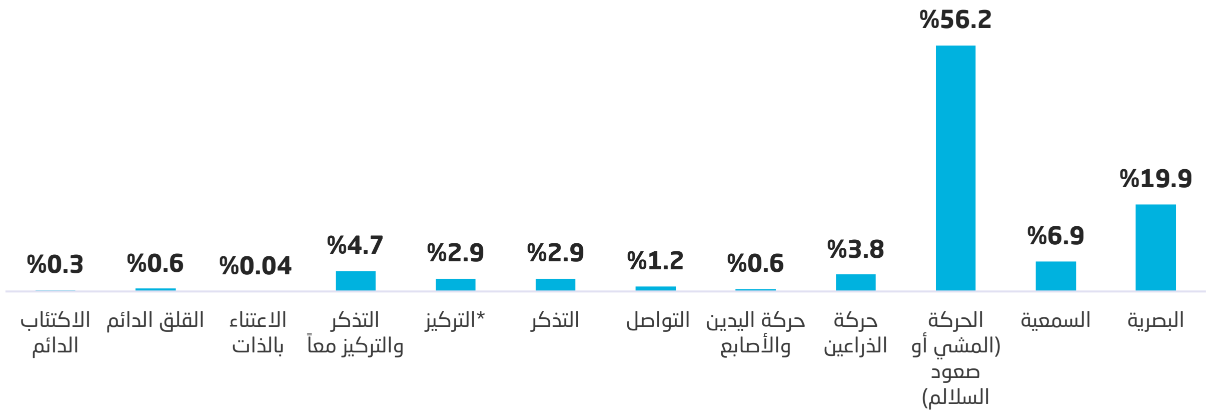
*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 2: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة الواحدة حسب نوع الإعاقة للفئة العمرية (5 -17 سنة)



*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 3: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة الواحدة حسب نوع الإعاقة للفئة العمرية (18سنة فأكثر)



*التركيز ليس لها مستوى درجة.

*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشر 1.4: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة حسب أسباب الإعاقة والفئة العمرية

الفئة العمرية	أسباب خلقية	أسباب أثناء الحمل	عوامل أثناء الولادة	حوادث سير	كبر سن	بسبب المرض	أخطاء طبية	أخرى
4-2	%52.4	%7.0	%30.6	%0.2	-	%8.6	%0.5	%0.8
17-5	%50.4	%3.8	%21.3	%1.4	-	%20.1	%0.9	%1.9
18 فأكثر	%21.0	%0.9	%5.5	%5.5	%20.2	%44.2	%0.9	%1.8
الإجمالي الكلي	%26.9	%1.5	%8.8	%4.7	%16.1	%39.2	%0. 9	%1.8

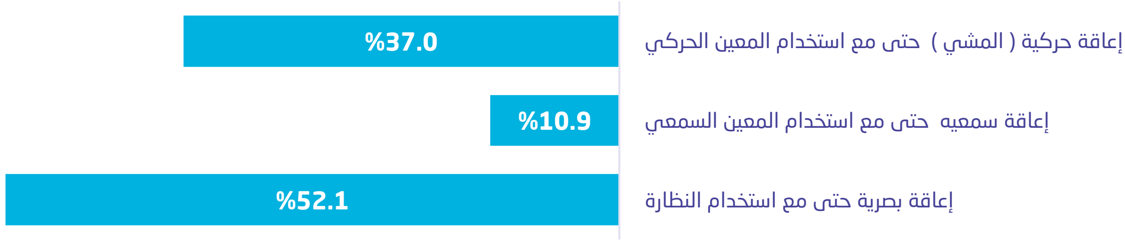
* تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشر 1.5: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة الواحدة للفئة العمرية (سنتان فأكثر) حسب استخدام المعينات.

التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة الواحدة حسب استخدام المعينات	
استخدام النظارة الطبية أو العدسات الطبية.	%63.4
استخدام المعين السمعي.	%10.3
استخدام المعين الحركي أو تلقي مساعدة على الحركة.	%26.3

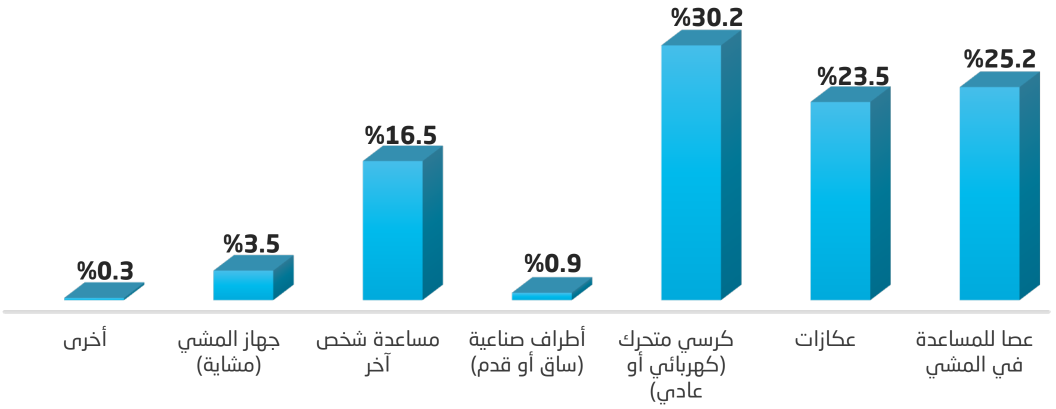
*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل4: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة الواحدة للفئة العمرية (سنتان فأكثر) حسب نوع الإعاقة واستخدام المعينات.



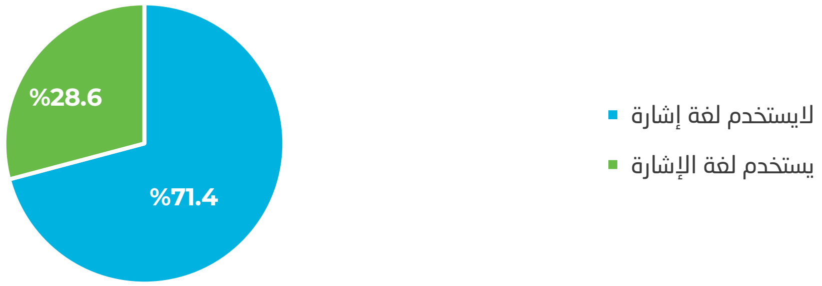
*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 5: التوزيع النسبي للمعينات الحركية المستخدمة من قبل الأفراد ذوي الإعاقة الواحدة: (18سنة فأكثر) الذين لديهم إعاقة حركية حتى مع استخدام المعين الحركي



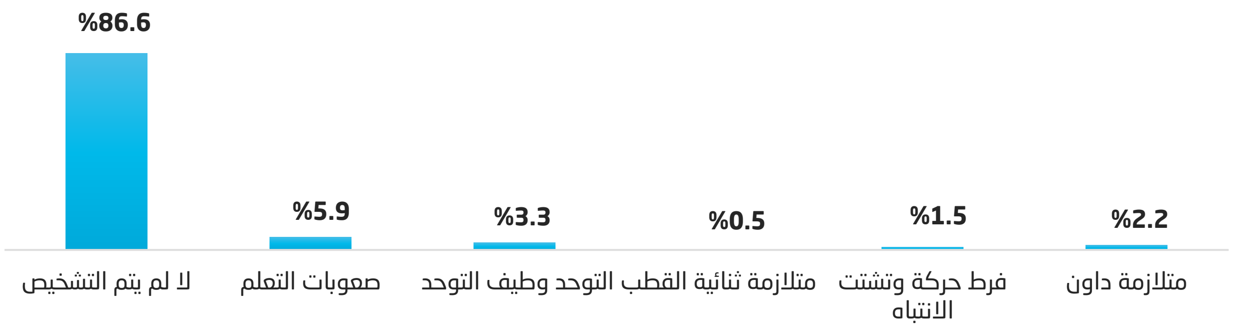
*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 6: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة الواحدة (18سنة فأكثر) الذين لديهم إعاقة في التواصل ويستخدمون لغة الإشارة.



*لا تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل7: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة حسب التشخيص بأحد الحالات (توحُّد وطيف التوحد , ومتلازمة داون، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، ومتلازمة ثنائية القطب، وصعوبات التعلم، ولم يتم التشخيص) للفئة العمرية (سنتان فأكثر)

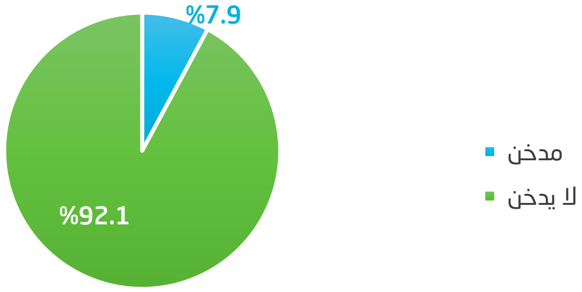


* تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشــر 1.6 التوزيع النســبي للأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر) الذين يستخدمون التبغ.

*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

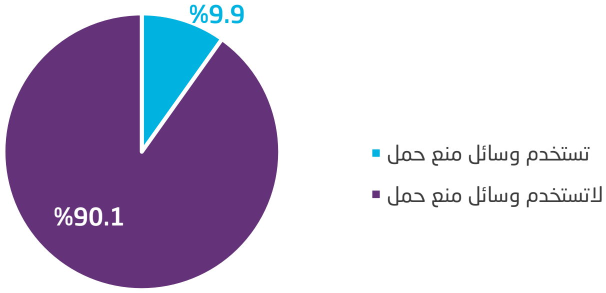
*مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG



المؤشر 1.7 التوزيع النسبي للإناث ذات الإعاقة (15 سنة فأكثر) المتزوجات اللاتي استخدمن وسائل منع الحمل.

*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

*مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG



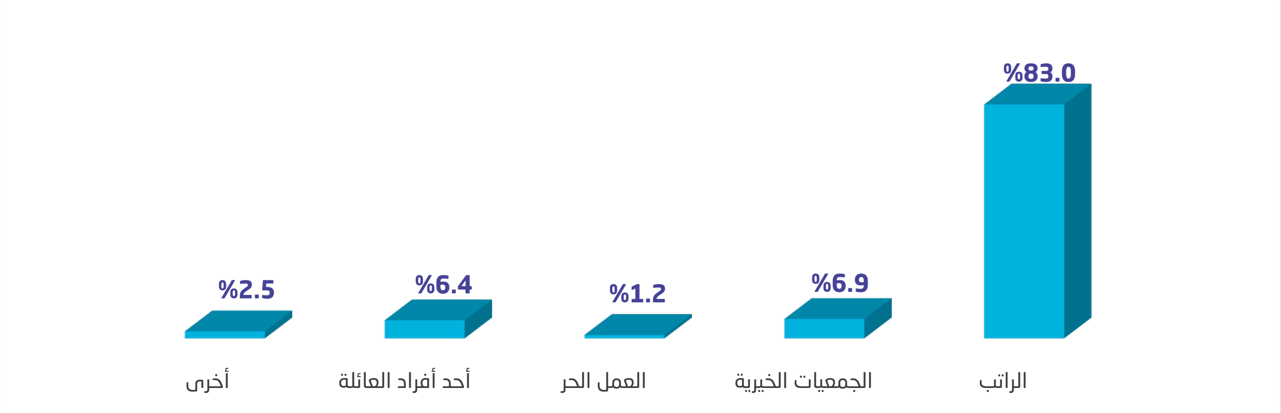
ثانيًا: المؤشرات العملية والاجتماعية:

المؤشر 2.1: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر) حسب التمكن من القراءة والكتابة.

التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر) حسب التمكن من القراءة والكتابة	
يتمكن من القراءة والكتابة	%68.8
لا يتمكن من القراءة والكتابة	%31.2

* تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 8: التوزيع النسبي لمصادر الدخل للأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر).



* تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

* يشمل الخيار أكثر من اختيار، ويشمل الأفراد ممن أجابوا عن الحالة العملية جميع الحالات (الإجابة عن الراتب تشمل أي دخل شهري للفرد، مثل أن يكون متعطلًا، ولكن لديه مصدر شهري).

المؤشر 2.2: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الاجتماعية:

- (%56.6) من الأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر) متزوجون.
- (%28.5) نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) غير متزوجين.

- * تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشر 2.2.1 التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر) حسب الجنس والحالة الاجتماعية:

الحالة الاجتماعية	ذكور	إناث	الجملة
لم يسبق له الزواج	%29.7	%26.9	%28.5
متزوج	%66.0	%45.3	%56.6
مطلق	%2.2	%4.6	%3.3
أرمل	%2.1	%23.2	%11.6

- * تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

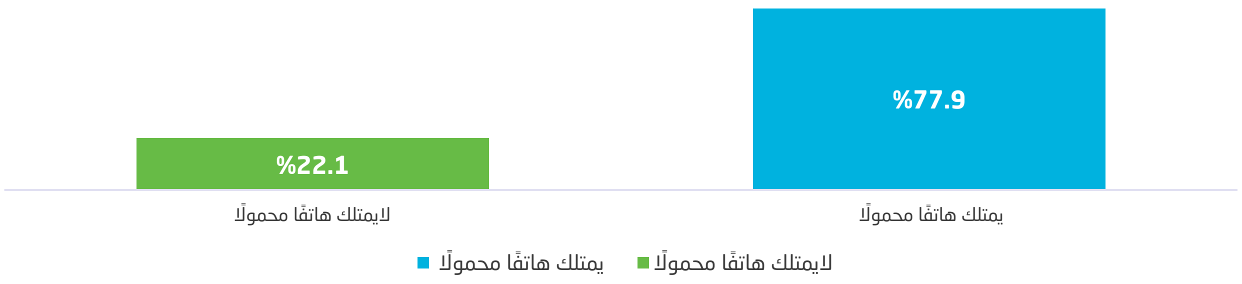
المؤشر 2.3: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الاجتماعية والعملية:

الحالة العملية	الحالة الاجتماعية			
	لم يسبق له الزواج	متزوج	مطلق	أرمل
لا يعمل ولا يبحث عن عمل	%28.2	%54.4	%2.9	%14.5
يعمل	%17.4	%78.5	%3.4	%0.7
يبحث عن عمل ولا يعمل	%43.6	%43.0	%5.2	%8.1

- * تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

ثالثًا: المؤشرات التنموية:

شكل 9: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) حسب امتلاك هاتف محمول



*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة .

*مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG

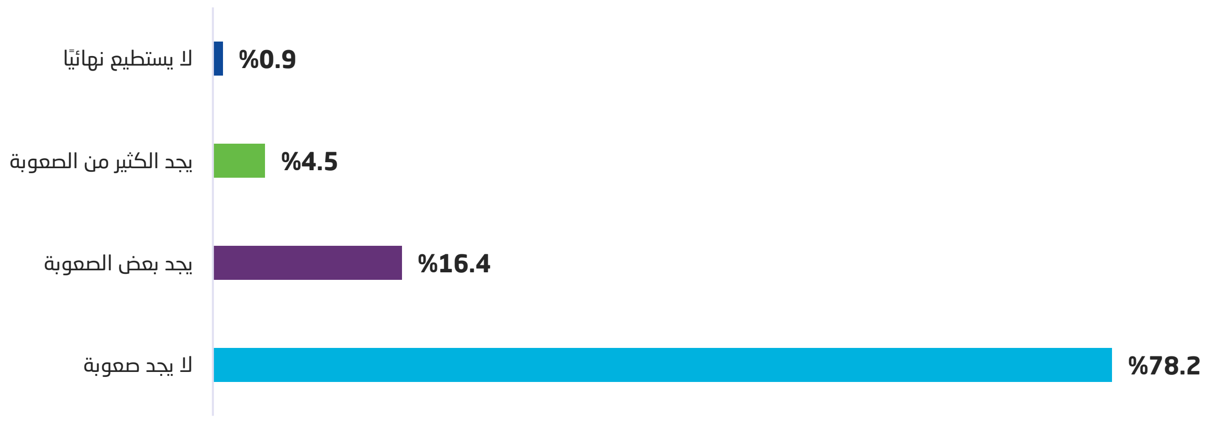
المؤشر 3.1: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) حسب استخدام الإنترنت:

التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) حسب استخدام الإنترنت	
يستخدم الإنترنت	%58.8
لا يستخدم الإنترنت	%41.2

*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة .

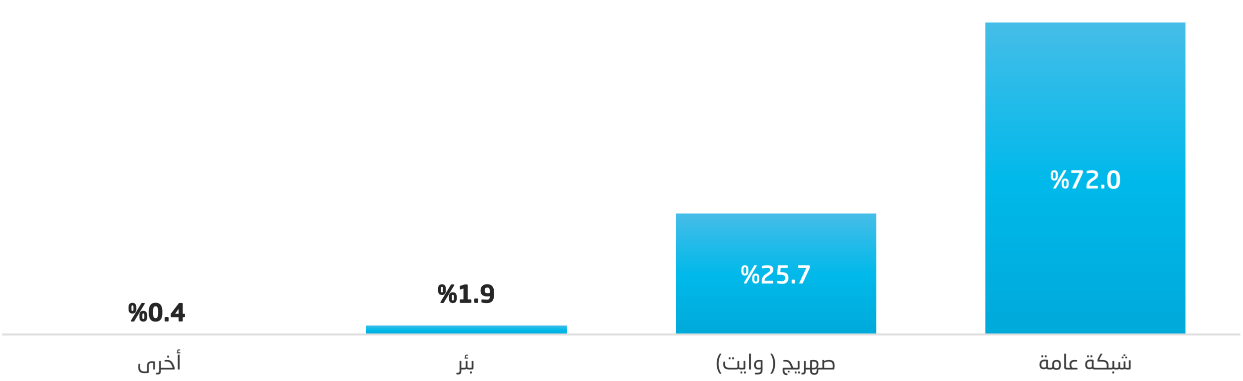
*مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG.

شكل 10: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) المستخدمين للإنترنت، ويجدون صعوبة في استخدام التطبيقات الإلكترونية.



*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

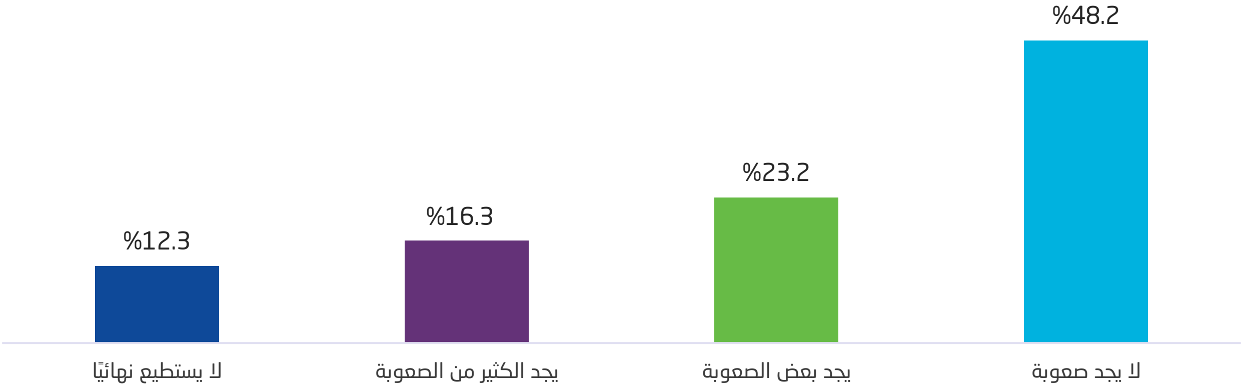
شكل 11: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة حسب استخدام مياه الشرب المأمونة.



*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

*مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG

شكل 12: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) وصعوبة الوصول إلى وسائل النقل العام والتنقل في الأماكن العامة.



*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

*مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG

المؤشر 3.2: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) حسب حالة الالتحاق بمراكز التأهيل:

- (%20.3) ملتحق بمراكز التأهيل.
- (%79.7) غير ملتحق بمراكز التأهيل.

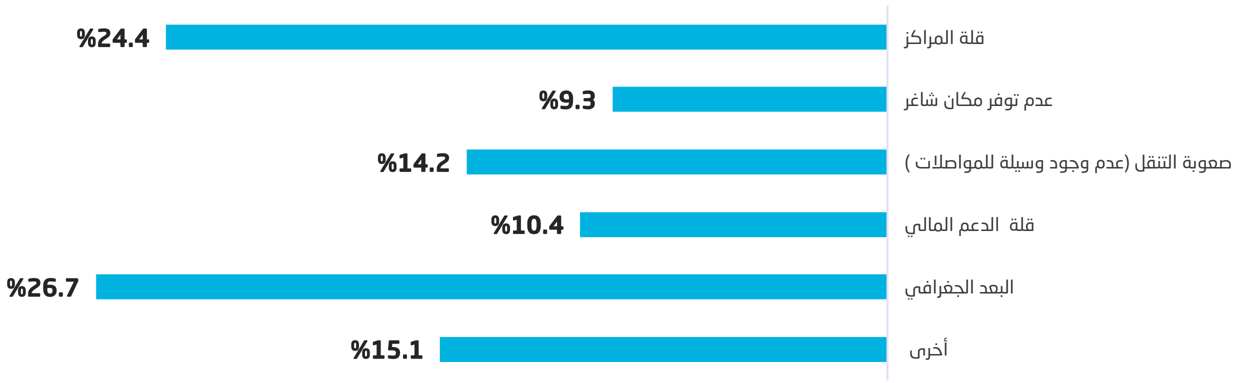
*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشر 3.2.1: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) حسب حالة الالتحاق بمراكز التأهيل والجنس:

حالة الالتحاق بمراكز التأهيل	الذكور	الإناث
ملتحق بمراكز التأهيل	%20.7	%19.8
غير ملتحق بمراكز التأهيل	%79.3	%80.2

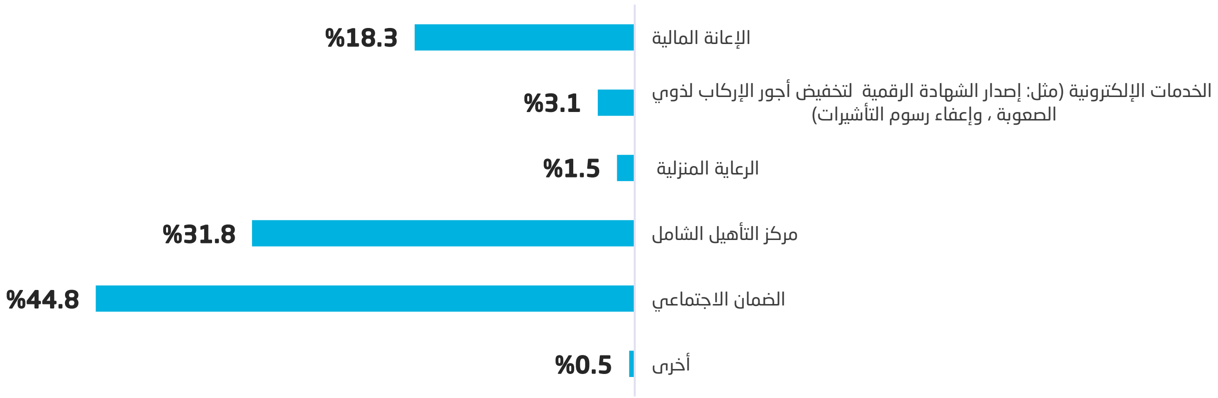
*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل13: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) حسب أسباب عدم الالتحاق بمراكز التأهيل.



*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 14: التوزيع النسبي لنوع الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد ذوي الإعاقة.



*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

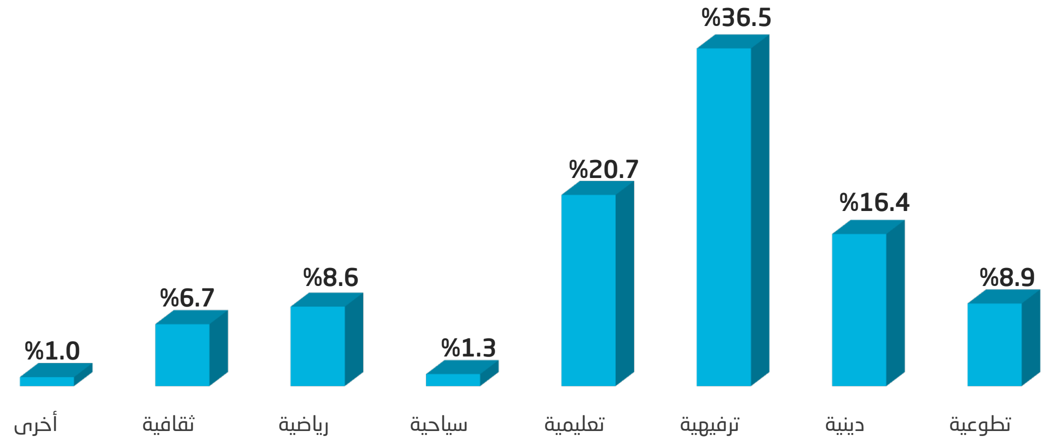
* يشمل الخيار أكثر من اختيار.

المؤشر3.3: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) حسب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية:

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية	
نعم (مشارك في الأنشطة الاجتماعية)	%26.0
لا (لا يشارك في الأنشطة الاجتماعية)	%74.0

- *تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 15: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة المشاركين في الأنشطة الاجتماعية (5 سنوات فأكثر) حسب نوع النشاط



- *تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

رابعًا: المؤشرات الأسرية:

المؤشر 4.1: التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم شخصًا واحدًا على الأقل من ذوي الإعاقة حسب المنطقة الإدارية:

نسبة الأسر التي لديها فرد واحد من ذوي الإعاقة حسب المنطقة الإدارية.

المنطقة الإدارية	النسبة
الرياض	%14.7
مكة المكرمة	%15.0
المدينة المنورة	%10.2
القصيم	%5.4
المنطقة الشرقية	%11.7
عسير	%7.8
تبوك	%6.0
حائل	%4.2
الحدود الشمالية	%3.8
جازان	%7.5
نجران	%5.8
الباحة	%4.4
الجوف	%3.6

- *تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

نسبة الأسر التي لديها أكثر من فرد واحد من ذوي الإعاقة حسب المنطقة الإدارية:

المنطقة الإدارية	النسبة
الرياض	%16.8
مكة المكرمة	%17.2
المدينة المنورة	%7.1
القصيم	%3.8
المنطقة الشرقية	%13.2
عسير	%7.4
تبوك	%4.7
حائل	%3.7
الحدود الشمالية	%3.0
جازان	%8.8
نجران	%6.7
الباحة	%4.5
الجوف	%3.1

- *تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشر 4.2: التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة حسب مستوى الإلمام بالتعامل الصحيح مع ذوي الإعاقة:

- (87.5%) من الأسر لديها إلمام كامل.
- (10.1%) من الأسر لديها إلمام متوسط.
- (2.0%) من الأسر لديها إلمام قليل.
- (0.5%) من الأسر ليس لديها إلمام.

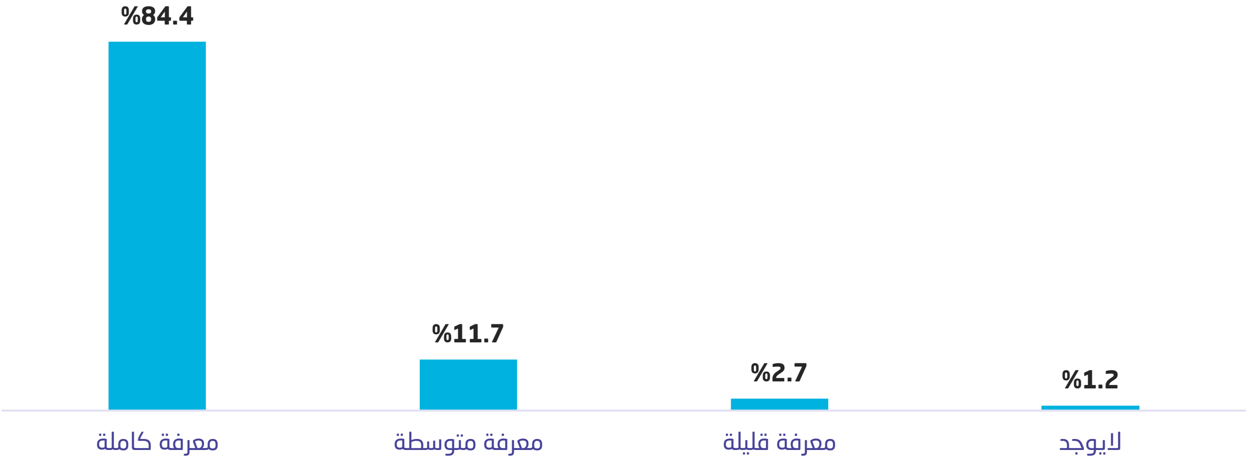
*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشر 4.3: التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة حسب مستوى الإلمام بالتعامل الصحيح مع ذوي الإعاقة ومصادر التثقيف.

مصادر التثقيف	مستوى إلمام الأسر المعيشية بالتعامل مع ذوي الإعاقة		
	إلمام كامل	إلمام متوسط	إلمام قليل
مراكز تأهيلية	%9.3	%7.5	%8.6
جمعيات خيرية	%0.4	%2.8	%1.9
اطلاع ذاتي	%26.0	%33.6	%30.9
مستشفيات	%64.3	%56.2	%58.6
أخرى (تُحدد)	%0.0	%0.0	%0.0

*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 16: التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة حسب درجة المعرفة بحقوق ذوي الإعاقة



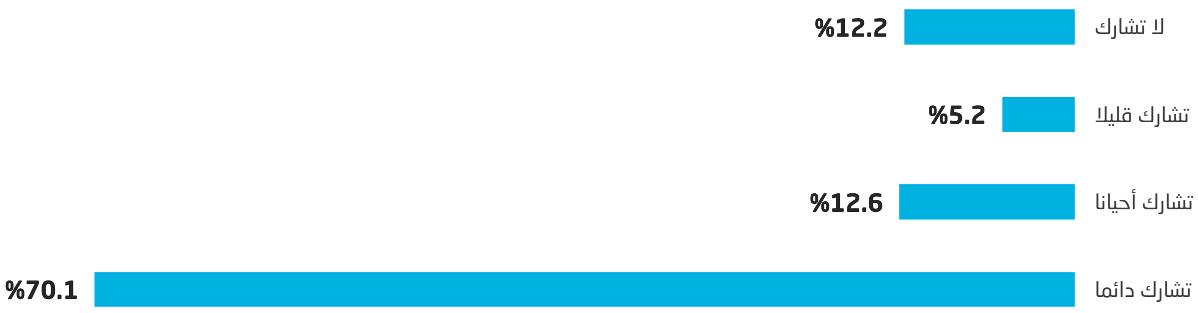
*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

المؤشر 4.4 التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة حسب تلقي معلومات كافية عن الحالة الصحية لذوي الإعاقة.

- (94.1%) من الأسر تلقت معلومات كافية عن الحالة الصحية للفرد ذي الإعاقة.
- (5.9%) من الأسر لم تتلقَّ معلومات كافية عن الحالة الصحية للفرد ذي الإعاقة.

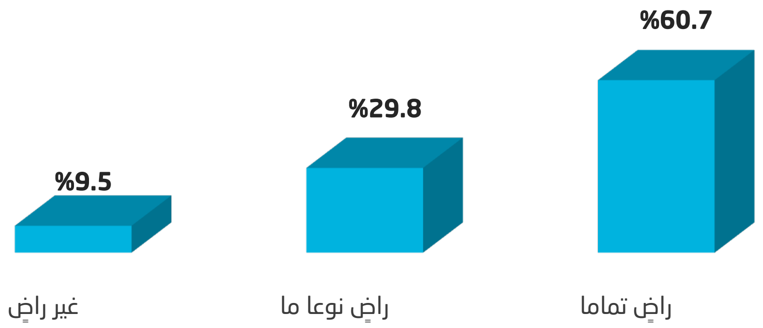
*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 17: التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة حسب المشاركة في العملية التعليمية والتأهيلية لهم



*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة

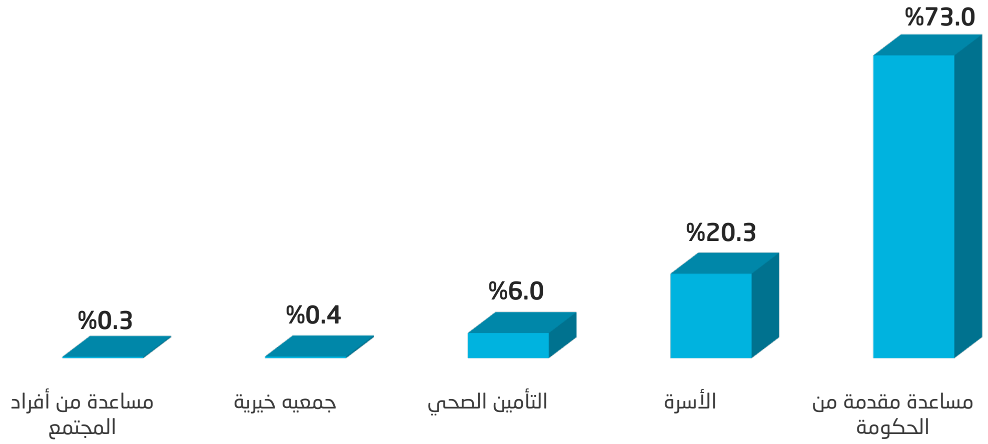
شكل 18: التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة حسب مستوى الرضا عن المساعدات المالية أو العينية المقدمة



(90.5%) إجمالي الأسر (التي تضم شخصًا واحدًا على الأقل من ذوي الإعاقة) الراضية تمامًا والراضية نوعًا ما عن المساعدات المالية أو العينية المقدمة لها.

*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة.

شكل 19: التوزيع النسبي لمن يتحمل تكاليف علاج ذوي الإعاقة

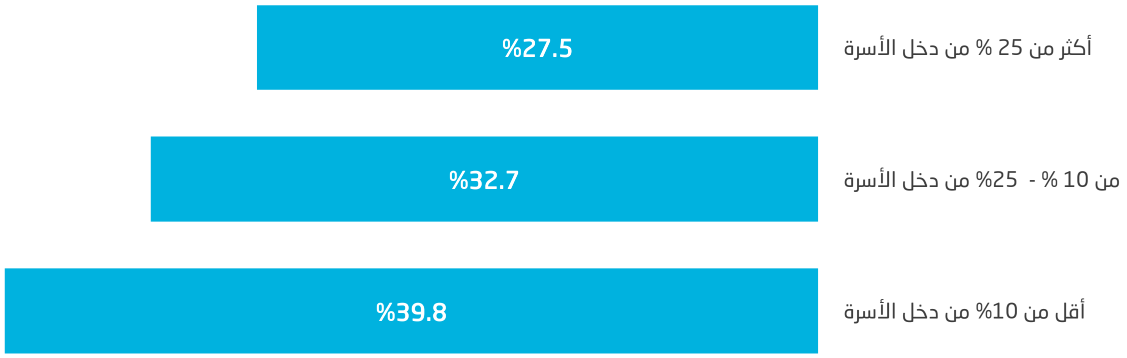


*يشمل الخيار أكثر من اختيار.

*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة .

*مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG

شكل 20: التوزيع النسبي لتحمل الأسرة المعيشية تكاليف علاج الفرد ذي الإعاقة

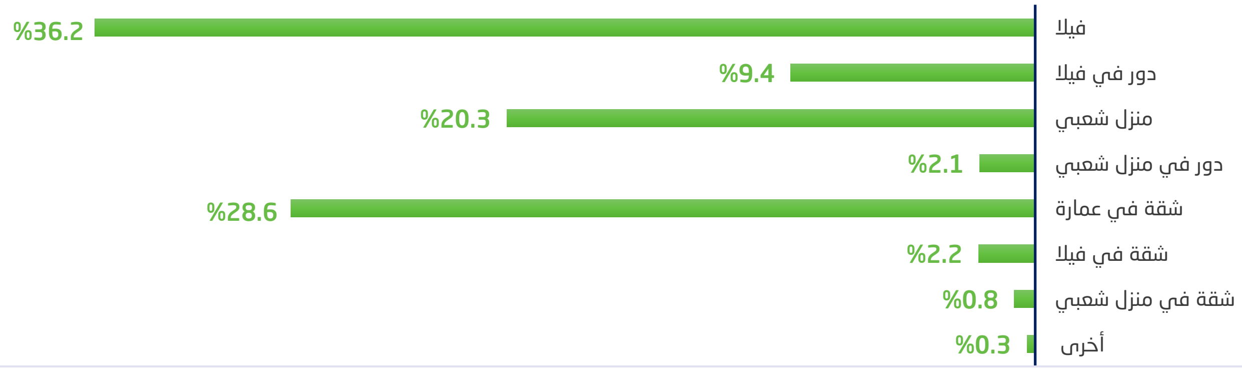


*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة .

*مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG

خامسا: مؤشرات المسكن:

شكل 21: التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة حسب نوع المسكن



*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة .

المؤشر 5.1: التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة حسب نوع الحيازة:

نوع الحيازة	قيمة المؤشر
ملكية بلا رهن ولا قرض	%51.0
ملكية برهن أو قرض	%21.6
مستأجر	%23.2
مقدم من العمل الحكومي	%0.7
مقدم من العمل الخاص	%0.3
مقدم من فاعل خير	%0.4
مقدم من الجمعيات الخيرية	%0.3
مقدم من أحد أفراد العائلة	%2.4
أخرى	%0.1

*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة .

المؤشر 5.2: التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة حسب مكان الإقامة الدائم:

مكان الإقامة	النسبة
الأسرة	%95.5
لدى أحد الأقارب	%1.7
دور الرعاية الاجتماعية	%0.0
مفرد (مستقل)	%2.4
المستشفيات	%0.4

*دور الرعاية الاجتماعية للأعمار من 60 فأكثر.

*مفرد مستقل للأعمار 18 سنة فأكثر.

*تشمل البيانات الصعوبة الخفيفة .

الهيئة العامة للإحصاء
General Authority for Statistics

65
عاماً
YEARS

تقرير

إحصاءات الأشخاص ذوي الإعاقة

2023

stats.gov.sa